

CAPÍTULO 8.22

Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico en Niños, Constipación y Fecaloma

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cirugía Pediátrica I: Enterocolitis, Invaginación, Divertículo de Meckel y Pólipos Juveniles

1. Enterocolitis Necrotizante (ECN)

- **¿Quién?** Recién nacido (no el 1er día; días 2–7 o más)
- **Factores predisponentes principales:**
 - 1. **Prematuridad** (más importante)
 - 2. Asfixia perinatal
 - 3. **Sepsis** neonatal

Clínica — Tríada

- **Vómitos o retención gástrica**
- **Distensión abdominal**
- **Hematoquecia** (deposiciones con sangre)

Diagnóstico

- **Radiografía simple de abdomen**

TABLA 8.22.1: SIGNO RADIOLÓGICO VS SIGNIFICADO	
SIGNO RADIOLÓGICO	SIGNIFICADO
Dilatación de asas intestinales	Frecuente, inespecífico
Neumatosis intestinal	Patognomónico de ECN (aire en la pared intestinal)
Neumoperitoneo	Perforación (complicación grave)

EUNACOM CRITERIOS

Neumatosis intestinal = ECN. Es el signo más característico en el EUNACOM.

Tratamiento

- **Régimen cero** (suspender toda alimentación oral/enteral)
- **Nutrición parenteral total** (EV)
- **Suero fisiológico EV**
- **Antibióticos EV** (por translocación bacteriana y riesgo de sepsis)
- **Cirugía** → solo si hay:
 - - Neumoperitoneo (perforación)
 - - Estenosis o fístula
 - - Falla al tratamiento médico

2. Invaginación Intestinal (Intususcepción)

- **¿Quién?** Lactante, más frecuente entre **6–12 meses**
- **Causa:** habitualmente idiopática (el intestino se introduce en sí mismo)
- - A veces: causa anatómica (divertículo de Meckel, pólipo)

Clínica

- **Crisis de llanto** con hiperflexión de caderas (el dolor pasa y vuelve)
- **Heces en mermelada** (deposiciones rojo-oscuras con moco — "mermelada de grosella")
- Masa palpable en cuadrante inferior derecho (a veces)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave EUNACOM: lactante de 8 meses con llanto episódico + deposiciones en mermelada de frutilla = **invaginación intestinal**.

Diagnóstico

- **Ecografía abdominal** (de elección)

- Imagen de **signo de la dona** (corte transversal) o **signo de la herradura** (corte longitudinal)

Tratamiento

- **Reducción neumática** (insuflación de aire por vía endoscópica/enema) — **primera línea**
- Si falla: reducción hidrostática
- Si falla: **cirugía** (última línea, no la primera)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El tratamiento NO es la cirugía de entrada. Es la **reducción neumática** primero.

3. Divertículo de Meckel

- **Causa:** persistencia **incompleta** del conducto onfalomesentérico (la completa produce fístula onfalomesentérica)
- **¿Quién?** Niño de cualquier edad (malformación congénita); generalmente asintomático
- **Localización:** íleon distal (yeyuno)
- **Contiene:** mucosa gástrica heterotópica → puede secretar ácido → úlcera → sangrado

Presentación Clínica

TABLA 8.22.2: FORMA VS CLÍNICA	
FORMA	CLÍNICA
Hemorragia digestiva baja (más frecuente)	Sangrado rectal indoloro, a veces grave
Diverticulitis de Meckel	Igual a apendicitis (abdomen agudo en FID; el apéndice está normal al explorar)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de los 2 de Meckel: - 2% de la población - 2 pies del íleon terminal - 2 cm de longitud - 2 años = edad más frecuente de presentación - 2 tipos de mucosa ectópica (gástrica y pancreática)

Diagnóstico

- **Cintigrafía con Tecnecio-99m** (la mucosa gástrica capta el trazador)
- No se ve en colonoscopia (está en íleon)

Tratamiento

- Cirugía: resección del divertículo

4. Pólipos Juveniles

- **¿Quién?** Escolar (5–10 años), preescolar mayor
- **Clínica:** hematoquecia **escasa** e **intermitente** desde hace semanas/meses — **niño se ve bien**
- Examen físico normal (no se palpa el pólipo)
- **Causa:** hamartoma vascular (malformación, no premaligno)

Diferencial con Divertículo de Meckel

TABLA 8.22.3: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	DIVERTÍCULO DE MECKEL	PÓLIPO JUVENIL
Hemorragia	Abundante , a veces grave	Escasa , crónica
Estado general	Puede deteriorarse	Normal
Diagnóstico	Cintigrafía Tc-99m	Colonoscopia
Tratamiento	Cirugía	Resección colonoscópica

Tratamiento

- Colonoscopia + resección del pólipo (polipectomía colonoscópica)

5. Hematemesis en el Recién Nacido — Test de Apt-Downey

TABLA 8.22.4: RESULTADO VS INTERPRETACIÓN		
RESULTADO	INTERPRETACIÓN	CONDUCTA
Vira a amarillo	Sangre de la madre (hemoglobina adulta se desnaturaliza)	Tranquilizar + mejorar técnica de lactancia
Permanece rojo	Sangre fetal del recién nacido	Endoscopia digestiva alta + manejo de HDA

NOTA CLÍNICA

El recién nacido puede deglutir sangre del pezón materno → llega hematemesis o sangre fecal. El test de Apt-Downey diferencia sangre materna (adulta) de sangre fetal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 2 meses alimentado con lactancia materna exclusiva presenta regurgitaciones frecuentes de leche no digerida tras casi todas las tomas. No presenta tos, ni dificultad respiratoria, ni irritabilidad; su curva de crecimiento y peso se mantiene en el percentil 50."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Reflujo Gastroesofágico Fisiológico del Lactante ('Regurgitador Feliz'): debido a la inmadurez fisiológica del esfínter esofágico inferior y dieta líquida. No requiere exámenes complementarios ni fármacos (no usar IBP ni proquinéticos). Manejo: medidas posturales (mantener en posición vertical 20-30 minutos tras la toma), fraccionar tomas y tranquilizar a los padres.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Reflujo fisiológico: lactante feliz, pico 2-6 meses, desaparece al año; solo requiere educación
- Reflujo patológico: mal incremento ponderal, hemorragia, síntomas respiratorios; tratamiento de elección es omeprazol
- No confundir reflujo con estenosis hipertrófica del píloro (vómitos explosivos entre semanas 2-6, diagnóstico ecográfico, pilorotomía de Ramstedt)
- Dolor abdominal crónico psicógeno: causa más frecuente en niños, periumbilical, aumenta con estrés escolar
- El fecaloma es la causa más frecuente de masa abdominal pediátrica; clínica incluye pseudoincontinencia y encopresis
- Desimpactación: polietilenglicol oral de elección; alternativa enema; última línea proctoclisis
- Mantenimiento: laxantes al menos 4 semanas + formación de hábitos de defecación y alimentación

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (REFLUJO DEL LACTANTE, DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN NIÑOS, CONSTIPACIÓN Y FECALOMA)**PREGUNTA 1**

Lactante de 3 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta regurgitaciones frecuentes después de cada alimentación. Se ve activo, con buen incremento ponderal y examen físico normal. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Iniciar omeprazol
- B) Realizar pHmetría esofágica
- C) Educar y tranquilizar a los padres
- D) Iniciar domperidona
- E) Solicitar ecografía abdominal

PREGUNTA 2

Niño de 8 años consulta por dolor abdominal periumbilical de 3 meses de evolución que aumenta los lunes al ir al colegio y desaparece en vacaciones. Examen físico normal, sin baja de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Enfermedad celíaca
- B) Síndrome de intestino irritable
- C) Dolor abdominal crónico psicógeno
- D) Giardiasis
- E) Constipación crónica

PREGUNTA 3

Niño de 5 años con antecedente de constipación crónica consulta por dolor abdominal y manchas fecales en la ropa interior. Al examen se palpa masa en hipogastrio y al tacto rectal se palpa masa dura. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado?

- A) Dieta rica en fibra y agua
- B) Polietilenglicol oral
- C) Extracción manual del fecaloma
- D) Cirugía abdominal
- E) Laxantes osmóticos crónicos

RESUMEN: REFLUJO DEL LACTANTE, DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN NIÑOS, CONSTIPACIÓN Y FECALOMA

Clase que aborda tres temas de gastroenterología pediátrica: reflujo del lactante, dolor abdominal crónico en niños y constipación con fecaloma. El reflujo del lactante se divide en fisiológico (lactante feliz, pico entre 2-6 meses, desaparece al año) que solo requiere educación, y patológico (mal incremento ponderal, hemorragia digestiva, síntomas respiratorios, ALTE) que se trata con omeprazol como primera línea. La funduplicatura de Nissen es de última línea. No confundir con estenosis hipertrófica del píloro (vómitos explosivos entre semanas 2-6, diagnóstico ecográfico, pilorotomía de Ramstedt). El dolor abdominal crónico en niños requiere buscar signos de alarma. Sin alarma, lo más probable es dolor psicógeno (aumenta con estrés escolar, localización periumbilical). Con alarma, se estudia con imágenes. La constipación funcional en niños genera un círculo vicioso (constipación - fisura - dolor - miedo - más constipación). El fecaloma es la complicación más frecuente y causa más frecuente de masa abdominal pediátrica. El manejo tiene dos fases: desimpactación (polietilenglicol oral de elección, o enema, o proctoclisís) y luego mantenimiento (laxantes por al menos 4 semanas + formación de hábitos).